

CAPÍTULO 14.23

Esquema General de Vasculitis

PERFIL EUNACOM 1.05.1.011
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Las **vasculitis** constituyen un grupo heterogéneo de enfermedades caracterizadas por la inflamación de las paredes de los vasos sanguíneos. Esta inflamación produce compromiso de la integridad vascular, lo que puede derivar en isquemia, necrosis tisular o formación de aneurismas.

En el contexto del examen EUNACOM, es fundamental reconocer que, aunque se clasifican por el tamaño del vaso afectado, las manifestaciones suelen ser sistémicas y potencialmente graves.

Clasificación General de las Vasculitis

Para organizar el estudio de las vasculitis, primero debemos diferenciar su origen:

- **Vasculitis Primarias:** Son enfermedades per se, donde el proceso patológico principal es la inflamación vascular sin una causa subyacente identificable.
- **Vasculitis Secundarias:** Ocurren como una complicación o manifestación de otra patología. Ejemplos clásicos incluyen el **Lupus Eritematoso Sistémico**, la **Artritis Reumatoide**, infecciones (como Hepatitis B o C) o reacciones a fármacos.

NOTA CLÍNICA

La fisiopatología de las vasculitis suele involucrar mecanismos de autoinmunidad, como el depósito de complejos inmunes o la presencia de anticuerpos específicos (ANCA), que atacan las células endoteliales o los constituyentes de la pared vascular.

Clasificación por Tamaño de Vaso

Aunque el tamaño del vaso no es la única forma de clasificarlas, sigue siendo la estructura mental más útil para el diagnóstico diferencial.

TABLA 14.23.1: CALIBRE DEL VASO VS ENFERMEDAD		
CALIBRE DEL VASO	ENFERMEDAD	VASOS PRINCIPALMENTE AFECTADOS
Grandes Vasos	Arteritis de Takayasu	Aorta y sus ramas principales (subclavia, carótidas).
Grandes Vasos	Arteritis de Células Gigantes (Temporal)	Carótida y sus ramas extracraneales; también subclavia.
Vasos Medianos	Poliarteritis Nodosa (PAN)	Arterias renales, mesentéricas y de órganos viscerales.
Vasos Medianos	Enfermedad de Kawasaki	Arterias coronarias (especialmente en niños).
Vasos Pequeños	Granulomatosis con Poliangiitis (Wegener)	Capilares, vénulas y arteriolas de vía aérea y riñón.
Vasos Pequeños	Poliangiitis Microscópica (PAM)	Capilares pulmonares y glomerulares.
Vasos Pequeños	G. Eosinofílica con Poliangiitis (Churg-Strauss)	Vasos pequeños asociados a asma y eosinofilia.
Vasos Pequeños	Púrpura de Schönlein-Henoch	Vasos pequeños con depósitos de IgA (piel, GI, riñón).

Vasculitis de Vasos Grandes

1. Arteritis de Takayasu

Afecta predominantemente a la **aorta y sus ramas principales**, como la subclavia y las carótidas. Es más frecuente en mujeres

jóvenes. Puede presentarse como la "enfermedad sin pulsos" debido a la estenosis de las grandes arterias.

2. Arteritis de Células Gigantes (Arteritis de la Temporal)

Afecta a pacientes mayores de 50 años. Se localiza típicamente en las ramas de la **carótida externa** (arteria temporal), pero también puede comprometer la carótida interna y las subclavias. - **Clave clínica:** Cefalea, claudicación mandibular y riesgo de ceguera súbita por compromiso de la arteria oftálmica.

Vasculitis de Vasos Medianos

1. Poliarteritis Nodosa (PAN)

Afecta arterias musculares de mediano calibre, frecuentemente las **arterias renales y mesentéricas**. - **Dato importante:** Se asocia clásicamente a la infección por **Hepatitis B**. - A diferencia de las vasculitis de vaso pequeño, la PAN **no suele afectar los capilares glomerulares** (no produce glomerulonefritis verdadera), pero sí causa isquemia renal por compromiso de las arterias pre-glomerulares.

2. Enfermedad de Kawasaki

Es una vasculitis febril aguda de la infancia. Su mayor peligro es la inflamación de las **arterias coronarias**, lo que puede llevar a la formación de aneurismas y muerte súbita.

Vasculitis de Vasos Pequeños (Asociadas a ANCA)

Estas son consideradas las vasculitis más graves en la práctica clínica del internista debido a su evolución rápida y daño orgánico severo.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Las vasculitis ANCA positivo suelen presentarse con la tríada: 1. **Compromiso Renal:** Glomerulonefritis rápidamente progresiva con falla renal aguda. 2. **Compromiso Pulmonar:** Alveolitis hemorrágica (hemoptisis masiva). 3. **Compromiso de Nervio Periférico:** Mononeuritis múltiple.

1. Granulomatosis con Poliangiitis (Wegener)

Se caracteriza por inflamación granulomatosa. - **Vía aérea superior:** Rinosinusitis crónica, úlceras nasales, nariz en "silla de montar". - **Vía aérea inferior:** Nódulos pulmonares cavitados y hemorragia. - **Riñón:** Glomerulonefritis. - **Serología:** Típicamente **c-ANCA (anti-PR3)** positivo.

2. Poliangiitis Microscópica (PAM)

Similar al Wegener pero **sin granulomas**. Afecta principalmente el riñón y el pulmón (síndrome riñón-pulmón). - **Serología:** Típicamente **p-ANCA (anti-MPO)** positivo.

3. Granulomatosis Eosinofílica con Poliangiitis (Churg-Strauss)

Se define por la presencia de **asma grave de difícil manejo**, eosinofilia periférica importante y granulomas. - **Serología:** También asociada a **p-ANCA**.

Manifestaciones Clínicas Transversales

Existen ciertos hallazgos que deben hacernos sospechar una vasculitis sistémica de inmediato:

- **Mononeuritis Múltiple:** Es la afectación asimétrica y sucesiva de varios troncos nerviosos (ej. caída del pie, luego debilidad en la mano). Se produce por la inflamación de la *vasa nervorum*.
- **Púrpura Palpable:** Manifestación clásica de las vasculitis de vaso pequeño en la piel.

- **Síntomas Constitucionales:** Fiebre de origen desconocido, baja de peso y compromiso del estado general.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Ante un paciente con falla renal rápidamente progresiva asociada a síntomas respiratorios (hemoptisis o sinusitis), siempre se debe descartar una vasculitis de vaso pequeño. El inicio precoz de corticoides e inmunosupresores es vital para salvar la función del órgano.

Resumen para el EUNACOM

- **Takayasu:** Mujer joven, aorta, ausencia de pulsos.
- **Células Gigantes:** >50 años, cefalea, VHS muy elevada, riesgo visual.
- **Kawasaki:** Niño, fiebre prolongada, compromiso coronario.
- **PAN:** Dolor abdominal (isquemia mesentérica), mononeuritis múltiple, asociación con Hepatitis B.
- **Wegener:** Sinusitis + Hemoptisis + Falla Renal (c-ANCA).
- **Churg-Strauss:** Asma + Eosinofilia (p-ANCA).
- **PAM:** Hemorragia alveolar + Glomerulonefritis (p-ANCA).
- **Schönlein-Henoch:** Niño con dolor abdominal, artralgias y púrpura en glúteos/extremidades inferiores tras infección respiratoria.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"¿Cuáles son las vasculitis ANCA positivo?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Esquema General de Vasculitis. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Vasculitis primarias (enfermedad per se) vs secundarias (complicación de lupus, AR, etc.)
- Vaso grande: arteritis de Takayasu (aorta) y arteritis de células gigantes (carótidas y ramas)
- Vaso mediano: enfermedad de Kawasaki (coronarias) y poliarteritis nodosa (renales y mesentéricas)
- Vaso pequeño: Schönlein-Henoch y las tres ANCA positivo (Wegener, PAM, Churg-Strauss)
- Las vasculitis ANCA positivo son las más graves: glomerulonefritis rápidamente progresiva, alveolitis hemorrágica, mononeuritis múltiple
- Mononeuritis múltiple se ve tanto en vaso pequeño ANCA positivo como en poliarteritis nodosa

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ESQUEMA GENERAL DE VASCULITIS)**PREGUNTA 1**

¿Cuáles son las vasculitis ANCA positivo?

- A)** Takayasu, Kawasaki y poliarteritis nodosa
- B)** Wegener, poliangeítis microscópica y Churg-Strauss
- C)** Arteritis de células gigantes, Schönlein-Henoch y Kawasaki
- D)** Poliarteritis nodosa, Wegener y Takayasu
- E)** Kawasaki, Churg-Strauss y Schönlein-Henoch

PREGUNTA 2

¿Qué tipo de vaso afecta predominantemente la poliarteritis nodosa?

- A)** Vaso grande (aorta)
- B)** Vaso mediano (arterias renales y mesentéricas)
- C)** Vaso pequeño (capilares)
- D)** Solo venas
- E)** Arteriolas pulmonares

PREGUNTA 3

¿Qué complicación es típica de las vasculitis de vaso pequeño ANCA positivo?

- A)** Aneurisma coronario
- B)** Hipertensión renovascular
- C)** Glomerulonefritis rápidamente progresiva
- D)** Claudicación de extremidades superiores
- E)** Crisis renal esclerodérmica

RESUMEN: ESQUEMA GENERAL DE VASCULITIS

Esta clase introductoria organiza la clasificación de las vasculitis. Existen vasculitis primarias (enfermedad per se) y secundarias (complicación de lupus, artritis reumatoide u otra enfermedad autoinmune). Las vasculitis primarias se clasifican según el tamaño del vaso afectado, desde las de vaso grande hasta las de vaso pequeño. Las vasculitis de vaso grande incluyen la arteritis de Takayasu (aorta y sus ramas: subclavia, aorta descendente, carótidas) y la arteritis de células gigantes (carótidas y sus ramas, también subclavias). Las de vaso mediano incluyen la enfermedad de Kawasaki (coronarias) y la poliarteritis nodosa (arterias renales y mesentéricas). Las de vaso pequeño incluyen la púrpura de Schönlein-Henoch y las tres vasculitis ANCA positivo: granulomatosis de Wegener, poliangeítis microscópica (PAM) y granulomatosis eosinofílica con poliangeítis (Churg-Strauss). Las ANCA positivo son las más graves, con glomerulonefritis rápidamente progresiva, alveolitis hemorrágica y mononeuritis múltiple.